



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOTACJĘ

Aplikacja pacjenta „Wyjątkowe Serca”

Opis i założenia projektu — mobilna aplikacja wspierająca rodziców i opiekunów dzieci z wrodzonymi wadami serca: profil medyczny, leki i przypomnienia dawek, pomiary, historia INR oraz bezpieczne udostępnianie danych w rodzinie.

PLATFORMY	CENA DLA RODZIN	DLA KOGO	STATUS
Android + iOS	aplikacja bezpłatna	rodziny dzieci z WWS	wersja robocza gotowa

Interfejs w języku polskim • Publikacja w Google Play i App Store • Dokument spójny z kosztorysem projektu

Charakter dokumentu. Niniejszy załącznik opisuje cele, zakres funkcjonalny, założenia techniczne i organizacyjne, ochronę danych o zdrowiu oraz powiązanie prac z kosztorysem wniosku. Projekt dotyczy **dokończenia, publikacji w sklepach, dostosowania do wymogów RODO oraz utrzymania** aplikacji pacjenta — prace opierają się na istniejącym zapleczu cyfrowym fundacji (serwis, API, logika aplikacji pacjenta), a nie na budowie całego ekosystemu od zera.

Dokument w skrócie

Produkt	Bezpłatna aplikacja mobilna (Android + iOS) dla rodziców i opiekunów dzieci z WWS.
Zakres projektu	Dokończenie aplikacji, publikacja w Google Play i App Store, zgodność z RODO, utrzymanie przez 12 miesięcy.
Koszt roku 1	131 500 zł (600 h × 210 zł/h + koszty stałe).
Dane o zdrowiu	Art. 9 RODO — wyraźne zgody, ocena skutków (DPIA), przetwarzanie w UE.
Wkład własny	Robocza wersja aplikacji wraz z backendem wytworzona nieodpłatnie (ok. 180 h ≈ 38 tys. zł).

Spis treści

1. Cel projektu i grupa docelowa
2. Problem i uzasadnienie
3. Zakres funkcjonalny wersji 1 (v1) i poza zakresem
4. Przepływ użytkownika
5. Platformy, sklepy i architektura
6. Ochrona danych osobowych i danych o zdrowiu (RODO)
7. Harmonogram i kamienie milowe
8. Powiązanie z budżetem projektu
9. Utrzymanie po wdrożeniu
10. Oczekiwane efekty i mierniki — ostrożne szacunki
11. Podsumowanie

1 Cel projektu i grupa docelowa

Celem projektu jest udostępnienie rodzicom i opiekunom dzieci z wrodzonymi wadami serca (WWS) **wygodnej, bezpiecznej aplikacji mobilnej**, która w jednym miejscu gromadzi kluczowe informacje o stanie zdrowia dziecka potrzebne w codziennej opiece i na wizytach lekarskich: profil medyczny, leki i przypomnienia dawek, pomiary (m.in. saturacja, tętno, ciśnienie, diureza), historię badań INR oraz eksport czytelnego raportu PDF.

Aplikacja jest elementem misji Fundacji Wyjątkowe Serca — wspierania rodzin na ścieżce leczenia, a nie zastępowania personelu medycznego. Narzędzie ma charakter **rejestru i asystenta organizacyjnego** prowadzonego przez opiekuna, a nie systemu diagnostycznego ani dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy.

Główna grupa docelowa

- rodzice i opiekunowie prawni dzieci z wrodzonymi wadami serca (oraz — w razie potrzeby — starsi pacjenci korzystający z konta pod opieką rodziny);
- osoby współopiekujące się dzieckiem (np. drugi rodzic, babcia/dziadek), którym właściciel konta świadomie udostępni dostęp do tych samych danych;
- fundacja jako podmiot udostępniający narzędzie w ramach działalności statutowej (bez monetyzacji danych).

Język i dostępność

Interfejs aplikacji jest w języku polskim. Aplikacja działa na popularnych smartfonach z systemem Android; w ramach projektu finalizowana jest także publikacja na iOS, aby nie wykluczać rodzin korzystających z iPhone'ów. Interfejs projektowany jest z dbałością o czytelność (wyraźne kontrasty, duże elementy dotykowe, prosta nawigacja), a uwagi dotyczące dostępności zgłaszane przez użytkowników będą obsługiwane w ramach utrzymania.

2 Problem i uzasadnienie

Wrodzone wady serca są najczęstszymi z wad wrodzonych – w Polsce co roku rodzi się ok. 3 tys. dzieci z WWS (ok. 1% urodzeń). Rodziny dzieci z WWS na co dzień zarządzają dużą ilością informacji medycznych: harmonogramami leków (często z różnymi dawkami i częstotliwościami), wynikami INR istotnymi przy leczeniu przeciwkrzepliwym, pomiarami domowymi oraz historią operacji i wad. W praktyce dane te są rozproszone w notesach, zdjęciach wyników, arkuszach kalkulacyjnych i pamięci opiekunów. Utrudnia to przygotowanie do wizyty, przekazanie informacji drugiemu opiekunowi oraz zachowanie ciągłości opieki przy zmianie osoby sprawującej pieczę.

Istnieją ogólne aplikacje zdrowotne i notatniki, jednak **nie są one dopasowane** do specyfiki opieki nad dzieckiem z wadą serca (słownik wad i operacji, INR, leki z przypomnieniami, udostępnianie w rodzinie, eksport karty na wizytę). Fundacja dysponuje już zapleczem cyfrowym (strona, API, logika aplikacji pacjenta). Projekt dotacyjny pozwala **ukończyć wersję mobilną**, opublikować aplikację w oficjalnych sklepach, wzmocnić ochronę danych o zdrowiu oraz zapewnić rok stabilnego utrzymania.

Dlaczego aplikacja mobilna? Opiekunowie korzystają ze smartfona w szpitalu, w domu i w drodze. Natywna aplikacja umożliwia m.in. lokalne przypomnienia o dawkach i pomiarach, wygodne wprowadzanie danych oraz udostępnianie raportu PDF lekarzowi bez konieczności logowania się do wersji przeglądarkowej w trudnych warunkach.

3 Zakres funkcjonalny wersji 1 (v1) i poza zakresem

3.1. W zakresie v1 (przedmiot projektu)

Obszar	Opis funkcjonalny
Logowanie	Bezpieczne logowanie kontem Google (Android; spójnie z istniejącym API fundacji). Na iOS – logowanie Apple (wymóg sklepu przy logowaniu społecznościowym) oraz spójny model sesji.
Profil pacjenta	Dane identyfikacyjne i medyczne istotne dla WWS: m.in. imię i nazwisko dziecka, grupa krwi, wady serca, zaburzenia rytmu, rozrusznik, przebyte operacje, powikłania, choroby współistniejące, zespoły genetyczne – z automatycznym zapisem.
Leki	Lista leków, dawki, częstotliwość, historia podań, śledzenie kolejnej dawki, lokalne przypomnienia na urządzeniu (za zgodą użytkownika na powiadomienia systemowe).
Pomiary	Rejestr pomiarów domowych (m.in. saturacja, tętno, ciśnienie, diureza), notatki, przegląd historii i uproszczone wykresy, opcjonalne przypomnienie o pomiarach.
INR	Historia wyników INR / parametrów powiązanych, etykiety informacyjne (rejestr wyników, nie narzędzie diagnostyczne), przegląd trendów.
Raport PDF	Eksport czytelnej karty pacjenta (profil, leki, pomiary, INR) do udostępnienia np. na wizycie – generowany na żądanie użytkownika.
Udostępnianie w rodzinie	Właściciel konta tworzy zaproszenie (token z terminem ważności); druga osoba po zalogowaniu może dołączyć do tych samych danych. Właściciel widzi listę osób z dostępem i może go odwołać.
Publikacja	Przygotowanie i złożenie aplikacji w Google Play oraz App Store: materiały sklepowe, polityka prywatności, zastrzeżenie medyczne, proces weryfikacji aplikacji w sklepach.
RODO / dane o zdrowiu	Wyraźne zgody (w tym na dane o zdrowiu), aktualizacja dokumentacji pod aplikację pacjenta, prawo do usunięcia konta i danych, wzmocnienie zabezpieczeń API, podstawowy dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA).
Utrzymanie 12 mies.	Aktualizacje systemów (Android/iOS), poprawki błędów, drobne dostosowania interfejsu, utrzymanie hostingu w UE, wsparcie merytoryczne dla fundacji.

3.2. Poza zakresem v1

- diagnostyka medyczna, zalecenia terapeutyczne generowane automatycznie, „aplikacja medyczna” w rozumieniu wyrobu medycznego;
- panel lekarza / placówki medycznej, integracja z systemami P1 / e-dokumentacją medyczną podmiotów leczniczych;
- publiczna strona fundacji, sklep charytatywny i płatności darowizn (istnieją osobno; nie są przedmiotem tej linii budżetowej);
- tryb offline z pełną synchronizacją konfliktów (może być rozważany w przyszłości);
- powiadomienia push wysyłane z serwera – w v1 przypomnienia lokalne na urządzeniu;
- wersje językowe inne niż polski.

Świadome ograniczenie zakresu pozwala ukończyć produkt użyteczny dla rodzin, bezpieczny pod kątem danych o zdrowiu i możliwy do utrzymania przez fundację.

4 Przepływ użytkownika

Poniższy opis oddaje docelowy, spójny przebieg korzystania z aplikacji po publikacji w sklepach (z uwzględnieniem prac RODO i iOS przewidzianych w projekcie).

Krok	Działanie użytkownika	Wynik
1	Logowanie (Google lub Apple — zależnie od platformy); akceptacja regulaminu / zgód RODO (w tym na dane o zdrowiu)	Utworzenie lub odtworzenie sesji; wejście do aplikacji
2	Uzupełnienie profilu pacjenta (dane medyczne istotne dla opieki)	Zapis w bezpiecznym magazynie danych powiązany z kontem
3	Dodawanie leków, oznaczanie dawek; włączenie przypomnień (opcjonalnie)	Lokalne powiadomienia systemowe; historia podań
4	Wprowadzanie pomiarów i wyników INR	Historia, wykresy, etykiety informacyjne
5	Eksport raportu PDF na wizytę lub do drugiego opiekuna	Plik PDF do udostępnienia z urządzenia
6	Utworzenie zaproszenia dla współopiekuna; druga osoba akceptuje link z zaproszenia	Wspólny dostęp do danych; możliwość odwołania dostępu przez właściciela

Główne obszary nawigacji (zakładki)

- **Profil pacjenta** — dane stałe i historia operacji / wad;
- **Leki** — farmakoterapia i przypomnienia;
- **Pomiary** — rejestr parametrów domowych;
- **INR** — historia badań przeciwwkrzepliwych;
- oraz ścieżki pomocnicze: logowanie, akceptacja zaproszenia, eksport PDF, zarządzanie dostępami.

5 Platformy, sklepy i architektura

5.1. Platformy i dystrybucja

Element	Założenie
Android	Aplikacja pacjenta w Google Play; pakiet aplikacji fundacji; opłata deweloperska sklepu — jednorazowa.
iOS	Ta sama baza funkcjonalna; logowanie Apple; testy przedpremierowe i publikacja w App Store z konta deweloperskiego fundacji.
Cena dla użytkownika	Aplikacja bezpłatna; brak zakupów w aplikacji i subskrypcji.
Język sklepów	Opisy i materiały po polsku; polityka prywatności i zastrzeżenie medyczne dostępne przed pobraniem.

5.2. Architektura (zarys dla recenzenta, bez szczegółów wdrożeniowych)

Aplikacja mobilna komunikuje się z **dedykowanym API** fundacji hostowanym w chmurze w regionie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uwierzytelnianie opiera się na **logowaniu przez zaufanego dostawcę tożsamości** (token sesji weryfikowany po stronie API). Dane medyczne są zapisywane w bazie po stronie serwera i nie są publicznie dostępne bez zalogowania. Warstwa serwisowa jest współdzielona z istniejącym zapleczem cyfrowym fundacji, co ogranicza koszt i ryzyko dublowania infrastruktury.

Model dostępu: urządzenie użytkownika → szyfrowane połączenie HTTPS → API (weryfikacja tokenu) → magazyn danych w UE. Klienci mobilni i webowi nie uzyskują bezpośredniego, otwartego dostępu do całej bazy — tylko do zasobów wynikających z tożsamości i ewentualnego udostępnienia w rodzinie.

Technicznie aplikacja mobilna jest rozwijana w podejściu wieloplatformowym (wspólna logika biznesowa dla Android i iOS), co pozwala utrzymać spójność funkcji przy rozsądnym koszcie drugiej platformy oraz zachować bezpieczeństwo i utrzymywalność rozwiązania.

6 Ochrona danych osobowych i danych o zdrowiu (RODO)

Aplikacja przetwarza **dane o zdrowiu** (szczególna kategoria danych w rozumieniu art. 9 RODO): m.in. informacje o wadach serca, lekach, pomiarach i wynikach INR. Z tego względu projekt przewiduje środki wyższe niż przy zwykłych danych kontaktowych.

6.1. Podstawa i transparentność

- administrator danych: Fundacja Wyjątkowe Serca (dane rejestrowe i kontakt RODO w polityce prywatności);
- podstawa: świadczenie usługi aplikacji (art. 6 RODO) oraz **wyraźna zgoda** na przetwarzanie danych o zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit. a), zbierana w aplikacji w sposób oddzielny od marketingu;
- informacja o roli opiekuna prawnego przy danych dziecka;
- polityka prywatności zaktualizowana pod aplikację pacjenta — dostępna w aplikacji i w kartach sklepowych;
- jasna informacja przy zaproszeniu współopiekuna: druga osoba uzyska wgląd w pełny zakres danych medycznych udostępnionego profilu.

6.2. Środki techniczne i organizacyjne (w projekcie)

Obszar	Założenie w projekcie
Dostęp	Wyłącznie po zalogowaniu; autoryzacja po stronie API; brak publicznego odczytu kart pacjentów.
Szyfrowanie	Połączenia HTTPS; szyfrowanie danych w spoczynku po stronie dostawcy chmury w UE.
Region	Przetwarzanie w infrastrukturze w regionie EOG (centrum danych w UE).
Kopie zapasowe	Regularne kopie zapasowe bazy (retencja krótko- i średnioterminowa wg konfiguracji chmury).
Zabezpieczenia API	Ograniczenie publicznie zbędnej dokumentacji API, ochrona sekretów, limity zapytań, zawężenie uprawnień kont serwisowych.
Rozliczalność	Podstawowy dziennik zdarzeń dostępu (kto / kiedy / jaki zasób — bez zbędnego logowania treści klinicznej).
Prawa osoby	Podgląd i edycja własnych danych w aplikacji; usunięcie konta i powiązanych danych medycznych jako funkcja docelowa v1; eksport raportu PDF jako forma przenoszenia informacji na wizytę.
Ocena ryzyka	Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) dla przetwarzania danych o zdrowiu w aplikacji pacjenta.
Podmioty przetwarzające	Umowy / warunki powierzenia z dostawcami chmury i tożsamości (dostawcy infrastruktury w UE) — po stronie fundacji.

Zastrzeżenie medyczne. Aplikacja nie stawia diagnoz i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Moduł INR i etykiety wynikowe mają charakter pomocniczy / edukacyjny. Sformułowania w interfejsie i w opisach sklepowych będą spójne z tą zasadą, aby nie wprowadzać użytkowników w błąd co do charakteru narzędzia.

7 Harmonogram i kamienie milowe

Poniższy harmonogram ma charakter roboczy (miesiące od startu finansowania). Część prac produktowych jest już zaawansowana; projekt koncentruje się na ukończeniu prac, zgodności, publikacji i utrzymaniu.

Faza	Czas	Kamienie milowe
F1 — Analiza i doprecyzowanie zakresu	Miesiąc 1	Utrwalenie założeń (niniejszy opis), priorytety RODO i sklepów, plan testów na urządzeniach.
F2 — Produkt Android + iOS	Miesiące 1–3	Ukończenie funkcji v1, logowanie Apple, testy na urządzeniach, stabilizacja.
F3 — RODO i bezpieczeństwo	Miesiące 2–4	Zgody art. 9, usuwanie konta, wzmocnienie zabezpieczeń API, dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA), aktualizacja polityki.
F4 — Publikacja w sklepach	Miesiące 3–5	Konta deweloperskie fundacji, karty sklepowe PL, weryfikacja w Google Play i App Store, poprawki po weryfikacji.
F5 — Utrzymanie	Miesiące 1–12	Utrzymanie zaplecza od startu projektu, opublikowanej aplikacji — od publikacji; aktualizacje systemów, poprawki, monitoring hostingu, wsparcie fundacji.

Ryzyka i ich ograniczanie

Ryzyko	Sposób ograniczania
Wydłużona weryfikacja aplikacji przez sklepy (szczególnie App Store przy treściach zdrowotnych)	Bufor na poprawki w harmonogramie; zastrzeżenie medyczne i polityka prywatności przygotowane przed zgłoszeniem.
Brak zwolnienia z opłaty Apple Developer dla organizacji non-profit	Koszt awaryjny (ok. 500 zł/rok) możliwy do pokrycia w ramach środków utrzymaniowych.
Niska adopcja narzędzia przez rodziny	Aplikacja bezpłatna; promocja kanałami fundacji (rozdz. 10); rozwój na podstawie opinii rodzin.
Ograniczona dostępność wykonawcy	Wykonawca jest autorem wersji roboczej (pełna znajomość kodu); harmonogram z buforami; kod w repozytorium fundacji.
Zmiany wymogów sklepów lub przepisów	Dwunastomiesięczne utrzymanie obejmuje aktualizacje zgodnościowe.

8 Powiązanie z budżetem projektu

Poniższa tabela łączy bloki merytoryczne z kosztorysem wniosku. **Stawka referencyjna prac programistycznych: 210 zł/h.** W budżecie **nie ujęto** kosztów narzędzi warsztatu wykonawcy (środowisko programistyczne, oprogramowanie wspomagające prace deweloperskie itp.) – są wliczone w stawkę. Ujęto koszty bezpośrednio związane z produktem fundacji: prace, RODO, hosting, opłaty sklepowe.

Lp.	Pozycja	Godz.	Kwota (zł)
A. Wytworzenie aplikacji			
1	Analiza i projekt aplikacji mobilnej pacjenta	25	5 250
2	Implementacja Android (profil, leki, pomiary, INR, uwierzytelnianie, PDF, udostępnianie)	160	33 600
3	Implementacja i testy iOS + logowanie Apple	60	12 600
4	Integracja z API i usługami chmurowymi, stabilizacja	40	8 400
5	Publikacja Google Play + App Store (karty sklepowe, materiały, zastrzeżenie medyczne)	40	8 400
Suma A		325	68 250
B. Zgodność RODO / dane o zdrowiu			
6	Zgody art. 9, opiekun, polityka prywatności pod aplikację, komunikaty przy zaproszeniach	40	8 400
7	Usunięcie konta i danych w całym systemie (API, web, aplikacja mobilna)	25	5 250
8	Wzmocnienie zabezpieczeń API (sekrety, dokumentacja, limity zapytań, konta serwisowe)	30	6 300
9	Dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA), testy zgodności	30	6 300
10	Konsultacja / przegląd dokumentacji RODO (prawnik)	—	3 000
Suma B		125	29 250
C. Utrzymanie i infrastruktura (12 miesięcy)			
11	Praca programisty – utrzymanie, poprawki, aktualizacje platform	150	31 500
12	Hosting i chmura (API, baza, uwierzytelnianie, kopie zapasowe)	—	2 400
13	Google Play Console (opłata jednorazowa w roku 1)	—	100
14	Apple Developer Program (zwolnienie z opłaty dla organizacji non-profit – założenie)	—	0
Suma C		150	34 000
RAZEM ROK 1		600	131 500

Wkład własny fundacji – prace wykonane przed projektem. Robocza wersja aplikacji pacjenta (sekcja webowa, aplikacja mobilna i backend/API – zakres opisany w rozdz. 3) powstała w całości **nieodpłatnie**; na podstawie historii repozytorium kodu szacujemy ten wkład ostrożnie na **ok. 180 godzin** pracy o wartości **ok. 38 tys. zł** (wg stawki referencyjnej 210 zł/h). Autor wersji roboczej zrealizuje także prace objęte kosztorysem, co ogranicza ryzyko wdrożenia – kosztorys powyżej obejmuje wyłącznie prace przyszłe.

Mapowanie opisu → budżet

Część opisu projektu	Pozycje kosztorysu
Niniejszy dokument / analiza i projekt (rozdz. 1–5, 7)	Lp. 1
Zakres v1 Android, przepływ, funkcje medyczne	Lp. 2, 4
iOS, sklepy, zastrzeżenie medyczne, materiały	Lp. 3, 5
Ochrona danych (rozdz. 6)	Lp. 6–10
Utrzymanie i hosting (rozdz. 9)	Lp. 11–14

Szczegółowy kosztorys w formularzu wniosku powinien być tożsamy z powyższymi kwotami. W kolejnych latach szacowany koszt utrzymania (bez ponownego wytworzenia) wynosi ok. **36 000 zł rocznie** (ok. 160 h utrzymania i drobnych prac zgodnościowych + hosting).

9 Utrzymanie po wdrożeniu

Publikacja w sklepach nie kończy odpowiedzialności za narzędzie przetwarzające dane o zdrowiu. W ramach 12 miesięcy projektu przewidziano aktualizacje pod nowe wersje systemów Android i iOS, usuwanie zgłaszanych błędów, utrzymanie hostingu API i bazy wraz z kopiami zapasowymi, drobne zmiany interfejsu i treści (w tym komunikaty RODO) oraz wsparcie fundacji w komunikacji z rodzinami – zgodnie z zakresem z rozdz. 3 i pozycjami 11–12 kosztorysu.

Model długoterminowy: fundacja pozostaje właścicielem kont sklepowych, polityk i relacji z użytkownikami; prace programistyczne mogą być kontynuowane w trybie utrzymaniowym po zakończeniu okresu dotacji (szacunek – patrz rozdz. 8).

10 Oczekiwane efekty i mierniki – ostrożne szacunki

Projekt ma charakter **wsparcia organizacyjnego i informacyjnego** dla rodzin, a nie interwencji medycznej. Poniższe mierniki służą rozliczeniu działania narzędzia cyfrowego – bez obietnic skutków klinicznych.

Obszar	Przykładowy miernik	Uwagi
Dostępność	Publikacja w Google Play i (docelowo) App Store; aplikacja bezpłatna	Tak / nie + data publikacji
Zasięg	Co najmniej 200 instalacji i 100 aktywnych kont w 12 mies. od publikacji	Wartości docelowe ostrożne; wynik zależny od promocji fundacji
Użyteczność	Korzystanie z kluczowych funkcji (profil, leki, pomiary/INR, PDF)	Na podstawie statystyk zagregowanych, bez treści medycznej w raportach publicznych
Bezpieczeństwo / RODO	Wdrożone zgody, usuwanie konta, zaktualizowana polityka, DPIA	Lista kontrolna ukończenia fazy F3

Dotarcie do rodzin. Aplikacja będzie promowana kanałami własnymi fundacji (serwis internetowy, media społecznościowe, społeczność podopiecznych i ich rodzin) oraz przez materiały informacyjne przekazywane rodzicom, m.in. w ośrodkach kardiologii dziecięcej.

Czego projekt nie obiecuje: poprawy wskaźników klinicznych, skrócenia hospitalizacji ani zastąpienia opieki medycznej. Sukcesem jest dostępne, zrozumiałe i bezpieczne narzędzie, z którego rodziny realnie korzystają przy organizacji opieki nad dzieckiem z WWS.

11 Podsumowanie

Aplikacja pacjenta „Wyjątkowe Serca” odpowiada na konkretną potrzebę rodzin dzieci z wrodzonymi wadami serca: **uporządkowanie danych o zdrowiu i leczeniu w jednym, mobilnym, bezpiecznym narzędziu**. Projekt grantowy obejmuje ukończenie produktu na Androidzie i iOS, publikację w oficjalnych sklepach, wzmocnienie zgodności z RODO przy danych o zdrowiu oraz dwunastomiesięczne utrzymanie.

Całkowity koszt roku 1 według kosztorysu spójnego z niniejszym opisem wynosi **131 500 zł** (600 godzin prac programistycznych w stawce 210 zł/h oraz koszty stałe: prawnik RODO, hosting, Google Play). Dotychczasowa robocza wersja aplikacji wraz z backendem powstała w całości nieodpłatnie – to wkład własny fundacji szacowany na ok. 180 godzin pracy (ok. 38 tys. zł); dotacja finansuje wyłącznie prace przyszłe. Inwestycja wzmacnia misję fundacji w obszarze codziennego wsparcia rodziców – w sposób mierzalny, odpowiedzialny i możliwy do kontynuacji po zakończeniu dofinansowania.

Dokument przygotowany jako załącznik merytoryczny do wniosku o dofinansowanie. Nie stanowi pełnej dokumentacji prawnej (DPIA, umowy powierzenia, polityka prywatności – jako odrębne dokumenty fundacji) ani dokumentacji technicznej dla zespołu deweloperskiego.

Fundacja Wyjątkowe Serca · aplikacja pacjenta · opis projektu pod wniosek o dotację